

AFMCP Chap6 방어·수복: 만성 염증 Part 3 — 핵심 요약

1. 핵심 개념

- 기능의학은 염증의 '상류(upstream)' 인자를 다룸 — 약물은 하류 효과만 다룸
- NF-κB와 아라키돈산 경로 — 두 가지 핵심 염증 경로
- 같은 식품·성분이 두 경로 모두 억제: 생강, 강황, 마늘, 녹차, EPA·DHA
- 5R 프로토콜이 장 건강 + 만성 염증 해소의 핵심 도구

2. NF-κB 억제 핵심 식품·보충제

식품: 생강, 강황(커큐민), 녹차, 올리브오일, 마늘, 카이엔 고추

보충제: 오메가-3(EPA·DHA), 케르세틴, NAC, 강황 추출물

★ 강황+카이엔 조합 시 흡수율 향상

3. 아라키돈산 경로 차단 포인트

- PLA2: 감초, 케르세틴, 비타민 E
- COX: 브로멜라인, 생강, 케르세틴, 마늘, EPA·DHA
- LOX: 생강, 마늘, 강황, 어유, 녹차

4. 임상 플로우 경로 요약

① 임상 소견 확인 → ② ATM 파악 → ③ 환자 이야기 재구성 → ④ 식이/생활습관 우선 → ⑤ 장(5R) → ⑥ 노출/경험 → ⑦ 약물/전사인자 → ⑧ 결과 추적

5. 핵심 임상 진주(Clinical Pearls)

- 프로바이오틱스 내성 불량 = 장내세균 불균형 단서 → DIG IN 깊이 파고들 것
- 핸드아웃 적극 활용 — 환자가 '정보 폭탄' 받을 때 나침반이 됨
- 전식품 먼저, 효과 부족 시 치료 용량 보충제로 단계적 접근
- 불필요한 의사소통을 피하기 위해 전사인자 관련 영양·스트레스 인자에 집중